

MAUS-TRATOS — RECONHECER + PROTEGER + NOTIFICAR

TIPOS DE MAUS-TRATOS

Tipo	Características
Físico	Lesões corporais intencionais: hematomas, fraturas, queimaduras, TCE (shaken baby)
Negligência	Falha em prover necessidades básicas: alimentação, higiene, saúde, educação, supervisão
Psicológico	Humilhação, rejeição, ameaças, isolamento, exposição à violência doméstica
Sexual	Qualquer ato sexual com criança/adolescente; abuso, exploração, pornografia
Síndrome de Munchausen por procuração	Cuidador simula/provoca doença na criança para obter atenção médica

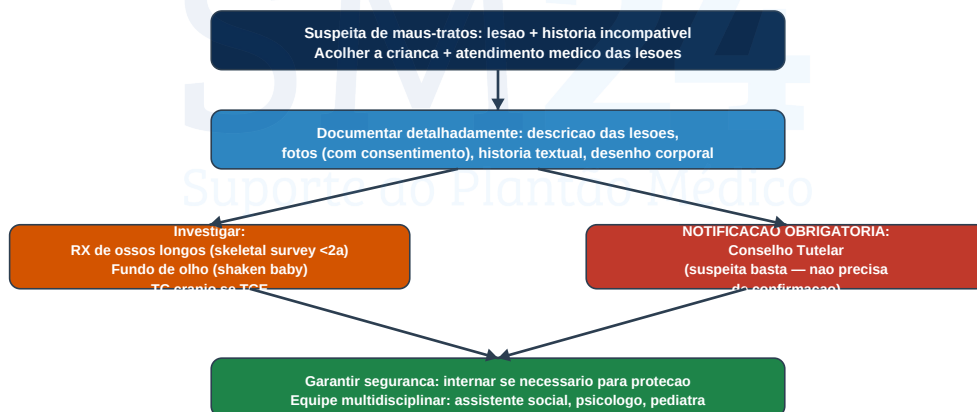
SINAIS DE ALERTA — QUANDO SUSPEITAR

RED FLAGS DE MAUS-TRATOS FÍSICOS

- História incompatível com a lesão ou com o estágio de desenvolvimento (ex: fratura em lactente que não anda)
- História mutável, contraditória ou atraso na procura por atendimento
- Lesões em estágios de cicatrização diferentes (hematomas de cores variadas)
- Localização atípica: orelhas, pescoço, tronco, genitais, região posterior (vs joelhos/canelas comuns)
- Lesões patognomônicas: marcas de objeto (cinto, fivela), queimadura em luva/meia (imersão), mordida humana
- Fraturas suspeitas: arcos costais posteriores, metáfise (canto/alça de balde), crânio complexa, em lactente

CONDUTA FRENTE À SUSPEITA

MAUS-TRATOS — PROTEGER + DOCUMENTAR + NOTIFICAR



NOTIFICAÇÃO — OBRIGAÇÃO LEGAL

ECA — ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- Notificação é OBRIGATÓRIA para todo profissional de saúde (Art. 13 do ECA + Lei 13.010)
- Basta a SUSPEITA — não é necessária confirmação do diagnóstico
- Notificar ao Conselho Tutelar (e ficha de notificação SINAN ao serviço de vigilância)
- A não notificação configura infração administrativa (multa) e pode haver responsabilização
- Não cabe ao médico investigar a autoria — apenas reconhecer, proteger e notificar
- Casos graves/risco iminente: acionar também autoridade policial e garantir internação protetiva

SÍNDROME DO BEBÊ SACUDIDO E ABUSO SEXUAL

Shaken Baby Syndrome

- Tríade: hematoma subdural + hemorragia retiniana + edema cerebral
- Mecanismo: sacudir violentamente o lactente (aceleração-desaceleração)
- Frequentemente: lactente que chora muito; sem sinais externos de trauma
- Investigação: fundo de olho + TC/RM crânio + skeletal survey
- Sequelas graves: cegueira, déficit neurológico, óbito
- Alta suspeita: rebaixamento/convulsão em lactente sem explicação clara

Suspeita de Abuso Sexual

- Sinais: ISTs em criança, gravidez, lesões genitais/anais, comportamento sexualizado
- Não revictimizar: exame por profissional capacitado, ambiente acolhedor
- Profilaxias: ISTs, HIV (PEP em <72h), contracepção de emergência se púbere
- Coleta forense: preservar evidências se <72h (cadeia de custódia)
- Notificação obrigatória + comunicação à autoridade policial
- Suporte psicológico à criança e à família protetora

DOCUMENTAÇÃO MÉDICA — IMPORTÂNCIA LEGAL

REGISTRAR COM CUIDADO

- ☐ Descrever lesões objetivamente: tipo, tamanho, cor, localização (diagrama corporal)
- ☐ Transcrever a história nas palavras do acompanhante e da criança (entre aspas)
- ☐ Fotografar as lesões com escala/régua (consentimento e protocolo institucional)
- ☐ Evitar termos conclusivos de autoria — descrever achados compatíveis
- ☐ Skeletal survey em <2 anos com suspeita de abuso físico (fraturas ocultas)
- ☐ Prontuário completo: pode ser documento legal — letra legível, datado, assinado

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Lactente de 4 meses com fratura de fêmur. A mãe relata que a criança 'rolou do sofá'. Qual conduta é correta?

- A) Aceitar a história, imobilizar e dar alta
- B) Suspeitar de maus-tratos (fratura incompatível com lactente que não se locomove) — investigar, proteger e notificar ao Conselho Tutelar
- C) Apenas tratar a fratura sem investigação adicional
- D) Encaminhar para ortopedia ambulatorial
- E) Solicitar apenas exame de cálcio e vitamina D

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

A notificação de suspeita de maus-tratos infantis pelo médico:

- A) Só deve ser feita após confirmação diagnóstica
- B) É obrigatória mesmo na suspeita, ao Conselho Tutelar (ECA Art. 13)
- C) Depende da autorização dos pais
- D) É facultativa e fica a critério do médico
- E) Só é necessária em casos de abuso sexual

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

A tríade da síndrome do bebê sacudido (shaken baby syndrome) inclui:

- A) Fratura de fêmur + hematoma + queimadura
- B) Hematoma subdural + hemorragia retiniana + edema cerebral
- C) Desnutrição + atraso de desenvolvimento + anemia
- D) Convulsão + febre + rigidez de nuca
- E) Hematoma epidural + fratura de crânio + otorragia

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Criança de 7 anos com diagnóstico de IST (gonorreia). Qual conduta NAO pode faltar além do tratamento da infecção?

- A) Apenas tratar a infecção e liberar
- B) Notificar suspeita de abuso sexual ao Conselho Tutelar + suporte multidisciplinar + profilaxias
- C) Prescrever antibiótico e orientar retorno em 7 dias
- D) Solicitar apenas sorologias e aguardar
- E) Encaminhar para ginecologia ambulatorial

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual achado de lesão é MAIS sugestivo de maus-tratos físicos?

- A) Hematoma em joelho de criança que está aprendendo a andar
- B) Escoriação em cotovelo após queda na escola
- C) Lesões em múltiplos estágios de cicatrização em localizações atípicas (tronco, orelhas, genitais)
- D) Hematoma único em canela de adolescente que joga futebol
- E) Equimose periorbital após trauma esportivo testemunhado

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Fratura de fêmur em lactente de 4 meses que não se locomove é altamente suspeita de maus-tratos (história incompatível com o desenvolvimento). Conduta: tratar a lesão + investigar (skeletal survey, fundo de olho) + proteger + NOTIFICAR ao Conselho Tutelar. A suspeita basta.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A notificação de maus-tratos é OBRIGATÓRIA na suspeita (ECA, Art. 13 + Lei 13.010). Não é necessária confirmação diagnóstica, nem autorização dos pais. Notifica-se ao Conselho Tutelar (e ficha SINAN). A não notificação é infração administrativa.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Síndrome do bebê sacudido (shaken baby): tríade de hematoma subdural + hemorragia retiniana + edema cerebral, por sacudir violentamente o lactente. Frequentemente sem sinais externos. Investigação: fundo de olho, TC/RM, skeletal survey. Sequelas graves ou óbito.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

IST em criança pré-púbere é forte indicador de abuso sexual. Além de tratar a infecção: notificar suspeita ao Conselho Tutelar + autoridade policial, suporte multidisciplinar (assistência social, psicologia), profilaxias (HIV/PEP se <72h, outras ISTs), e não revictimizar.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Lesões em múltiplos estágios de cicatrização (cores diferentes) em localizações atípicas (tronco, orelhas, pescoço, genitais) são altamente sugestivas de maus-tratos. Lesões em proeminências ósseas (joelhos, canelas, cotovelos) de crianças ativas são habituais e acidentais.

SM24
Suporte ao Plantão Médico